

1. Introducción y relevancia clínica

La **psoriasis** es una **enfermedad inflamatoria crónica e inmunomediada** que afecta principalmente la piel y, en algunos casos, las articulaciones.

Se caracteriza por **placas eritematoescamosas bien delimitadas**, con curso **crónico y recidivante**, que impacta significativamente la calidad de vida del paciente.

Relevancia clínica

- Prevalencia mundial: 2–3% de la población (≈200.000 personas en Chile).
 - Es un **trastorno sistémico**, con riesgo aumentado de **síndrome metabólico, obesidad, depresión y artritis psoriática**.
 - Suele debutar en adultos jóvenes, pero puede presentarse en cualquier edad.
 - En EUNACOM, es una **patología clásica** por su diagnóstico clínico y enfoque terapéutico escalonado.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La psoriasis resulta de una **interacción compleja entre predisposición genética y factores inmunológicos y ambientales**, que conducen a **hiperproliferación de queratinocitos y respuesta inflamatoria crónica**.

2.1. Genética y predisposición

- Concordancia alta en gemelos monocigóticos (60–70%).
- Asociaciones con antígenos del complejo HLA (especialmente **HLA-Cw6**).
- Herencia poligénica multifactorial.

2.2. Mecanismo inmunológico

- Activación de **células dendríticas** y **linfocitos T CD4+ y CD8+**, con liberación de **citocinas proinflamatorias (TNF- α , IL-17, IL-23, IL-22)**.
- Estas citocinas estimulan la **proliferación y maduración anormal de queratinocitos**, acortando su ciclo celular de 28 a 3–5 días.
- Resultado: acumulación de escamas y engrosamiento epidérmico.

2.3. Factores desencadenantes

- Estrés emocional.
- Infecciones (estreptocócicas, especialmente en psoriasis guttata).
- Medicamentos: betabloqueadores, litio, AINEs, antipalúdicos, corticoides sistémicos.
- Alcohol, tabaco, obesidad.
- Trauma cutáneo (*fenómeno de Koebner*).
- Clima frío y seco.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones cutáneas

Lesión elemental: **placa eritematosa bien delimitada con escamas plateadas adherentes**.

El **raspado** con una lámina metálica produce el **signo de la bujía** (caída de escamas) y, al final, el **signo de Auspitz** (pequeño sangrado puntiforme).

3.2. Tipos clínicos principales

Tipo	Características	Frecuencia / Observaciones
------	-----------------	----------------------------

Psoriasis en placas (vulgaris)	Placas eritematoescamosas bien delimitadas, simétricas, localizadas en codos, rodillas, cuero cabelludo y región lumbosacra	85–90% de los casos
Psoriasis guttata	Pequeñas pápulas de 2–10 mm, en forma de gotas, tras infección estreptocócica	Más común en niños y adolescentes
Psoriasis inversa (de pliegues)	Lesiones eritematosas lisas, sin escamas, en pliegues axilares, inguinales o submamarios	A menudo confundida con candidiasis
Psoriasis del cuero cabelludo	Escamas gruesas adheridas, con o sin extensión a la frente (signo de la corona)	Frecuente, puede confundirse con seborreica
Psoriasis ungueal	Punteado ungueal (“pitting”), hiperqueratosis subungueal, desprendimiento distal (onicólisis)	Asociada a artritis psoriática
Psoriasis pustulosa	Pústulas estériles sobre base eritematosa, generalizada o palmo-plantar	Potencialmente grave
Psoriasis eritrodérmica	Eritema y descamación difusa (>90% superficie corporal) con compromiso sistémico	Urgencia dermatológica

3.3. Localizaciones típicas

- Codos, rodillas, cuero cabelludo, región sacra.
- Pliegues (en forma invertida).
- Uñas (pitting, onicólisis).
- Palmas y plantas (hiperqueratosis).

- Mucosas: infrecuente.

3.4. Manifestaciones sistémicas

- **Artritis psoriática** (10–30% de los pacientes): dactilitis, dolor sacroilíaco, rigidez matinal.
- Asociación con **síndrome metabólico** (HTA, dislipidemia, obesidad).
- Riesgo cardiovascular aumentado.
- Impacto emocional: depresión, ansiedad, alteración de la autoestima.

3.5. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Dermatitis seborreica	Escamas más amarillentas, zonas seborreicas, menos bien delimitadas
Eccema crónico	Prurito más intenso, bordes difusos, exudado
Tiña corporis o capitis	Bordes activos, KOH positivo
Lupus cutáneo	Fotosensibilidad, atrofia central, anticuerpos positivos
Liquen plano	Lesiones planas, violáceas, poligonales, pruriginosas

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de psoriasis es **principalmente clínico**.

Se basa en:

- Morfología típica (placas eritematoescamosas bien delimitadas).
- Distribución característica (codos, rodillas, cuero cabelludo).
- Curso crónico y recidivante.
- Signos de raspado (bujía, Auspitz).

4.2. Exámenes complementarios

Examen	Indicación	Resultado esperado
Biopsia cutánea	Casos dudosos	Hiperqueratosis, paraqueratosis, elongación de crestas de Malpighi, microabscesos de Munro
Examen directo con KOH	Para descartar tiña	Negativo
Exámenes sistémicos	Antes de terapia sistémica	Hemograma, perfil hepático y renal, lípidos, PCR, glicemia

4.3. Índices de severidad

- **PASI (Psoriasis Area and Severity Index):** combina extensión y severidad (eritema, induración, descamación).
 - **BSA (Body Surface Area):** leve <3%, moderada 3–10%, severa >10%.
 - **DLQI (Dermatology Life Quality Index):** evalúa impacto en calidad de vida.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Objetivos

- Disminuir inflamación y descamación.
 - Mejorar calidad de vida.
 - Prevenir complicaciones y recurrencias.
 - Abordar comorbilidades asociadas.
-

5.2. Tratamiento escalonado

A. Psoriasis leve (BSA <3%)

Tratamiento tópico:

1. **Corticoides tópicos:** primera línea.
 - Potencia media-alta: betametasona, mometasona, clobetasol (por 2–4 semanas).
 - Evitar uso prolongado (atrofia, rebote).
 2. **Análogos de vitamina D3:** calcipotriol o calcitriol.
 - Pueden combinarse con corticoides tópicos.
 - Inhiben proliferación de queratinocitos.
 3. **Emolientes / queratolíticos (urea, ácido salicílico 3–6%):** favorecen eliminación de escamas.
 4. **Champús con alquitrán o ketoconazol** (para cuero cabelludo).
-

B. Psoriasis moderada (BSA 3–10%)

1. **Fototerapia (UVB banda estrecha):** opción eficaz en placas extensas.
2. **Combinación tópicos + fototerapia.**
3. **Educación y control del estrés.**

C. Psoriasis severa (BSA >10%) o refractaria

Terapia sistémica inmunomoduladora:

Fármaco	Dosis / esquema	Consideraciones
Metotrexato	7,5–25 mg/semana VO o SC + ácido fólico	Control hepático, renal y hematológico
Ciclosporina A	2,5–5 mg/kg/día	Uso corto (nefrotoxicidad, HTA)
Acitretina (retinoide)	0,3–0,5 mg/kg/día	Teratógeno, evita embarazo por 3 años
Biológicos (etanercept, adalimumab, secukinumab, ustekinumab)	Casos refractarios o con artritis psoriática	Supervisión dermatológica y precibado de TBC y hepatitis

Nota: MINSAL prioriza uso de biológicos en pacientes con DLQI >10 o PASI >10 sin respuesta a metotrexato o fototerapia.

5.3. Tratamiento de la artritis psoriática

- AINEs para dolor y rigidez.
 - Metotrexato o biológicos anti-TNF / anti-IL-17.
 - Evaluación reumatológica conjunta.
-

5.4. Medidas generales

- Evitar alcohol y tabaco.
- Controlar peso y comorbilidades metabólicas.
- Hidratación cutánea constante.
- Evitar traumatismos (fenómeno de Koebner).
- Educación sobre curso crónico y adherencia al tratamiento.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Características	Manejo
Artritis psoriática	Dolor e inflamación articular	Derivar a reumatología, DMARDs
Eritrodermia psoriática	Compromiso >90% SC, fiebre, riesgo vital	Hospitalización, control hidroelectrolítico
Psoriasis pustulosa generalizada	Fiebre, leucocitosis, pústulas estériles	Hospitalizar, tratamiento sistémico
Infecciones secundarias	Por excoriación o inmunosupresión	Antibióticos tópicos o sistémicos
Depresión / ansiedad	Frecuente	Abordaje integral
Síndrome metabólico	Dislipidemia, obesidad	Control cardiovascular y metabólico

Pronóstico:

- Curso crónico, con remisiones y exacerbaciones.

- Buena respuesta al tratamiento escalonado.
 - Los casos leves se controlan con tópicos; los graves requieren inmunomoduladores o biológicos.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Placas eritematoescamosas bien delimitadas en codos y rodillas → psoriasis vulgar.**
 2. **Signo de la bujía y de Auspitz** son clásicos de psoriasis.
 3. **Psoriasis guttata** suele aparecer tras infección estreptocócica.
 4. **Metotrexato** es el fármaco sistémico de primera elección en psoriasis severa.
 5. **Evitar suspender bruscamente corticoides sistémicos** (riesgo de pustulosis o rebote).
 6. **Descartar artritis psoriática** en todo paciente con dolor articular o dactilitis.
 7. **No confundir con dermatitis seborreica:** en psoriasis, las placas son más gruesas y secas.
-



Errores comunes

- Diagnosticar “caspa” en psoriasis del cuero cabelludo.
- Usar corticoides tópicos potentes en cara o pliegues.
- Prescribir corticoides sistémicos prolongadamente (efecto rebote).
- No evaluar comorbilidades metabólicas.

- No derivar casos graves o refractarios a dermatología.
 - No educar al paciente sobre la cronicidad y necesidad de mantención.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **psoriasis** es una enfermedad inflamatoria inmunomediada, crónica y recidivante.
2. Se caracteriza por **placas eritematoescamosas bien delimitadas** en áreas típicas (codos, rodillas, cuero cabelludo).
3. El **diagnóstico es clínico**; el raspado positivo (bujía y Auspitz) es orientador.
4. El **tratamiento es escalonado**: tópicos → fototerapia → sistémicos → biológicos.
5. **Metotrexato** es el fármaco sistémico de elección; **biológicos** se reservan para casos refractarios.
6. Siempre **evaluar comorbilidades** (artritis psoriática, síndrome metabólico, depresión).
7. En EUNACOM, la clave diagnóstica es: **placas eritematoescamosas bien delimitadas en codos o rodillas, curso crónico y prurito leve.**